Guía de manejo de **Belantamab mafodotina**

EN COMBINACIÓN CON
BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA (BVd)
O CON POMALIDOMIDA
Y DEXAMETASONA (BPd)

para pacientes de Mieloma Múltiple a partir de primera recaída

Con el aval científico de:

SEHH Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

GSK

Este material es de uso exclusivo para profesionales sanitarios

V1 Mayo 2026

Guía de manejo de **Belantamab mafodotina**

EN COMBINACIÓN CON BORTEZOMIB Y DEXAMETASONA (BVd) O CON POMALIDOMIDA Y DEXAMETASONA (BPd)

para pacientes de Mieloma Múltiple a partir de primera recaída

Revisores:

Arancha Bermúdez Rodríguez
Hematóloga. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Felipe de Arriba de La Fuente
Hematólogo. Hospital General Universitario Morales Meseguer. IMIB-Pascual Parrilla. Universidad de Murcia. Murcia

María Jesús Blanchard Rodríguez
Hematóloga. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Mercedes Gironella Mesa
Hematóloga. Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona

Nicolás Alejandre Alba
Oftalmólogo. Instituto de Microcirugía Ocular (IMO). Madrid

Noemí Puig Morón
Hematóloga. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

María Paula Chávez Collazos
Hematóloga. Hospital Universitario de Cabueñes. Asturias

Ricarda García Sánchez
Hematóloga. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

La divulgación científica está basada en datos publicados y accesibles y tiene una finalidad informativa/formativa. A tal efecto, los datos se presentan reflejando fielmente las publicaciones científicas sin ninguna modificación o añadido. Su contenido está protegido por derechos de autor y no puede ser reproducido (foto, grabación o "impresiones de pantalla"), ni divulgado ni transmitido a ningún tercero por cualquier medio, sin la autorización escrita de GSK.

Índice

1. RECURSOS 4

2. INTRODUCCIÓN 5

Necesidad médica no cubierta en primera recaída 6

¿Qué es belantamab mafodotina? 7

3. INDICACIÓN 11

Guía Europea EHA-EMN de Mieloma Múltiple 12

Guía Nacional del Grupo Español de Mieloma (GEM) 14

Hematoguía de MM de Castilla y León 14

4. ANTES DE UTILIZAR BELANTAMAB MAFODOTINA 17

Contraindicaciones 18

Medidas de soporte 18

Examen ocular previo a la infusión 20

5. POSOLOGÍA BELANTAMAB MAFODOTINA EN COMBINACIÓN 25

Poblaciones especiales 29

6. REACCIONES ADVERSAS Y SU MANEJO 31

Trombocitopenia 32

Reacciones infusionales 34

Neumonitis 36

Eventos oculares 36

Mecanismo por el que aparecen los eventos oculares 36

Posibles síntomas oculares asociados a belantamab mafodotina 38

Gradación de los eventos oculares 39

Recomendaciones sobre la modificación de dosis de belantamab mafodotina 43

Seguimiento de los eventos oculares por síntomas a partir de la cuarta dosis 47

7. REFERENCIAS 49

Recursos

Recursos accesibles en el QR:

- Atlas oftalmológico de los hallazgos corneales causados por belantamab mafodotina
- Programa de soporte a pacientes (PSP): información para hematólogos
- Programa de soporte a pacientes (PSP): información para oftalmología

Introducción

Necesidad médica no cubierta en primera recaída

La incorporación, en primera línea, de esquemas con inhibidores del proteasoma (IPs), inmunomoduladores (IMiDs) y anticuerpos monoclonales anti-CD38, ha supuesto una mejora notable en la calidad de la respuesta y la supervivencia de los pacientes con mieloma múltiple (MM)[1]. Sin embargo, el MM sigue considerándose una enfermedad incurable, donde la recaída es la norma. Varias circunstancias condicionan que el manejo de esta situación sea un reto:

- El porcentaje de pacientes que no llega a recibir la siguiente línea de tratamiento ("*attrition rate*") aumenta con el número de recaídas[1, 2].
- La elección del tratamiento de la recaída debe contemplar la situación de refractariedad a las terapias previas (incluso refractarios primarios). En este sentido, se debe priorizar aquellos esquemas que incorporan fármacos eficaces con distinto mecanismo de acción.
- Las circunstancias personales, clínicas y sociales de muchos pacientes con mieloma múltiple hacen que no puedan recibir terapias de alta complejidad en la primera recaída, y los esquemas tradicionales ofrecen una eficacia subóptima en términos de supervivencia libre de progresión (PFS, por sus siglas en inglés "*progression free survival*") y supervivencia global (OS, por sus siglas en inglés "*overall survival*").

Las terapias dirigidas contra la proteína BCMA (del inglés, antígeno de maduración de las células B) han revolucionado el manejo del MM[3]. La especificidad de esta proteína, que se expresa casi exclusivamente en las células plasmáticas, y su sobreexpresión en las plasmáticas malignas[4, 5], la convierte en una diana clínicamente relevante y ampliamente validada en MM.

Belantamab mafodotina es un nuevo tratamiento dirigido contra la diana BCMA, aprobado desde la primera recaída en combinación con bortezomib-dexametasona (BVd) y con pomalidomida-dexametasona (BPd). En los ensayos clínicos, BVd (DREAMM-7)[6] y BPd (DREAMM-8)[7] alcanzaron medianas de PFS de aproximadamente 3 años. En la comparativa frente a tripletes de uso habitual, en el estudio DREAMM-7 BVd demostró aumentar la PFS reduciendo en un 59% el riesgo de progresión/muerte frente a daratumumab-bortezomib-dexametasona (DVd) (hazard ratio [HR] = 0,41; IC del 95%, 0,31-0,53; P<0,001)[6] y aumentar la OS disminuyendo el riesgo de muerte en un 42% frente a DVd (HR= 0,58; IC del 95% 0,43–0,79; p=0,0002)[8]. En el estudio DREAMM-8, BPd demostró aumentar la PFS reduciendo en un 48% el riesgo de progresión/ muerte frente a pomalidomida-bortezomib-dexametasona (PVd) (HR= 0,52; IC del 95%, 0,37-0,73; P<0,001)[9].

BVd y BPd constituyen una nueva opción anti-BCMA con eficacia superior frente a tripletes estándar (DVd, PVd). Las combinaciones de belantamab mafodotina se administran de manera inmediata y ambulatoria, no necesitan premedicación y están disponibles en todos los hospitales para los pacientes con MM que a partir de primera recaída necesiten un anti-BCMA[10].

¿Qué es belantamab mafodotina?

Belantamab mafodotina es un anticuerpo conjugado (ADC, por sus siglas en inglés "*Antibody Drug Conjugate*") dirigido contra la diana BCMA (antígeno de maduración del linfocito B) (ADC anti-BCMA). Contiene un **anticuerpo monoclonal** humanizado afucosilado IgG1k, específico para BCMA (***belantamab***), y un **agente citotóxico**, monometil auristatina F (MMAF; cys-mcMMAF) (***mafodotina***)[10].

→ **Mecanismo de acción multimodal de belantamab mafodotina**[10, 11]**:**

- **Acción directa** (dependiente de la carga citotóxica-mafodotina).
  Induce respuestas rápidas y profundas.
  El anticuerpo belantamab se une al receptor de superficie celular BCMA en la superficie de las células plasmáticas y se internaliza rápidamente, liberando en el interior de la célula tumoral la carga citotóxica (mafodotina), que altera la red de microtúbulos y provoca la apoptosis o muerte celular.
- **Acción inmunomediada**
  Permite respuestas rápidas y duraderas.
  - **Inmunidad innata**
    En una primera línea de defensa inmediata, el anticuerpo potencia el reclutamiento y la activación de células inmunes efectoras, destruyendo las células tumorales por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC por sus siglas en inglés "*Antibody Dependent Cellular Citotoxicity*" y fagocitosis (ADCP, por sus siglas en inglés "*Antibody Dependent Cellular Phagocitosis*").
  - **Inmunidad adaptativa**
    Como consecuencia de la apoptosis inducida se liberan marcadores de muerte celular inmunogénica que pueden contribuir a la respuesta inmune adaptativa duradera, mediada por los linfocitos T contra las células tumorales (ICD, por sus siglas en inglés "*Immunogenic Cell Death*").
- **Inhibición de la proliferación de las células del mieloma**
  El anticuerpo se une al receptor de superficie celular BCMA, inhibiendo la unión de sus ligandos naturales de activación APRIL (ligando inductor de proliferación y BAFF (factor activador de célula). De esta manera también se reduce la proliferación y activación de la célula del mieloma que expresa BCMA.

Figura 1: **Mecanismo de acción de belantamab mafodotina**

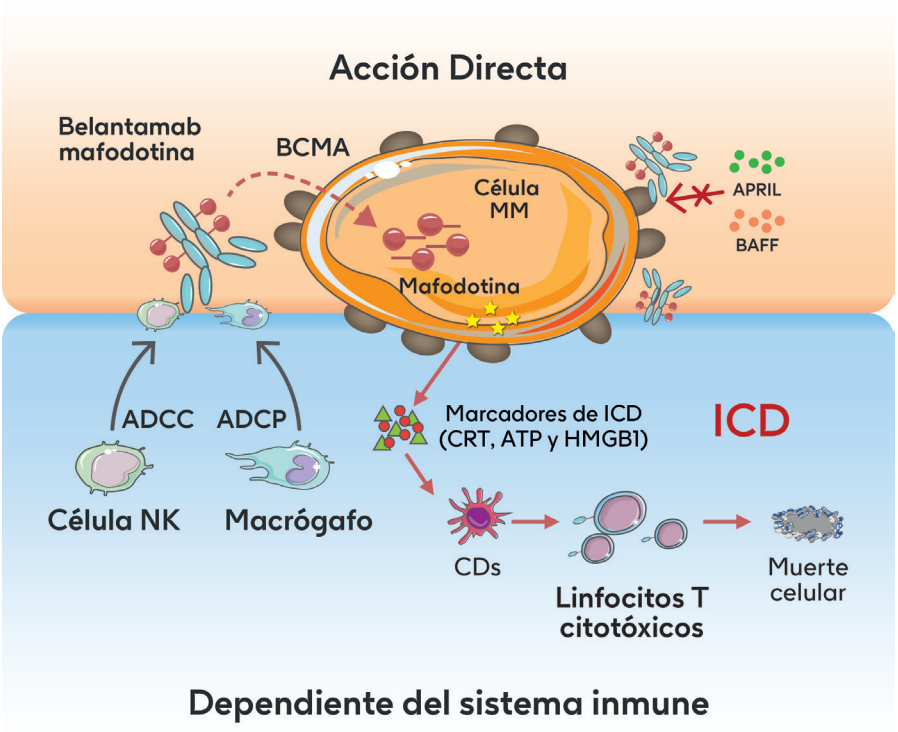


Imagen adaptada de Sheikh S, et al. Future Oncol. 2020[11].

ADCC: citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo; **ADCP:** fagocitosis celular dependiente de anticuerpo; **APRIL:** ligando inductor de proliferación o miembro de la superfamilia de ligandos del factor de necrosis tumoral; **BAFF:** factor activador de célula B; **BCMA:** antígeno de maduración de células B; **CD:** célula dendrítica; **ICD:** muerte celular inmunogénica; **MM:** mieloma múltiple; **NK:** asesina natural; **SI:** Sistema inmune.

Indicación

3

Indicación

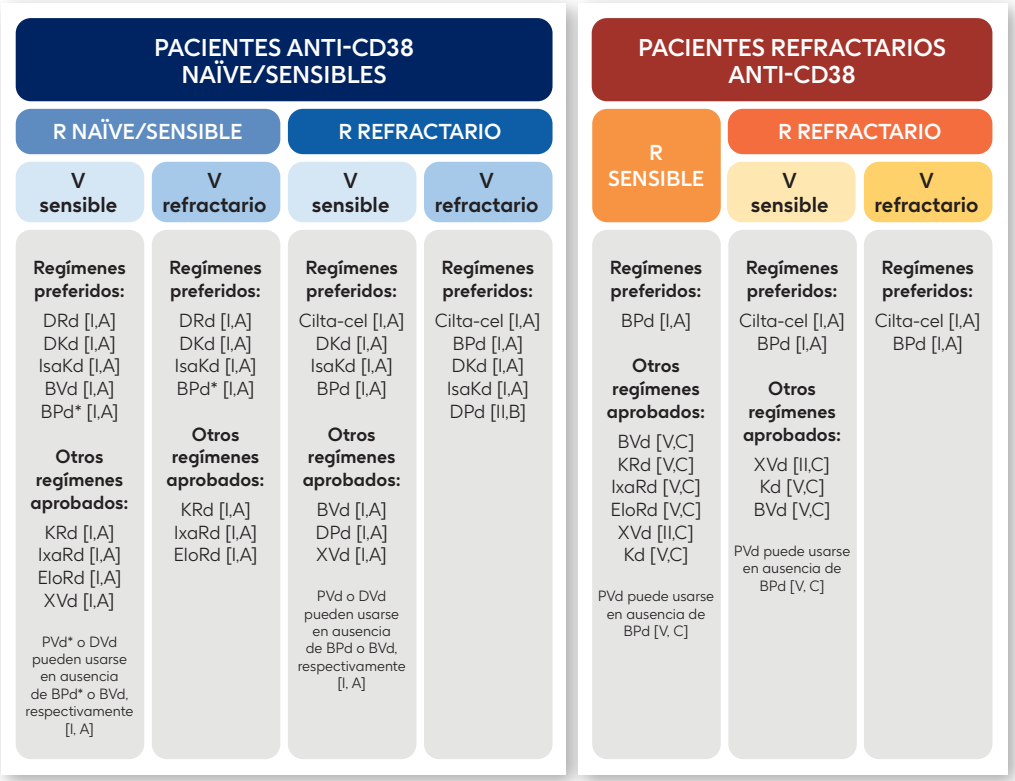
En julio de 2025, en base a los estudios **DREAMM-7** (BVd vs. DVd)[6] y **DREAMM-8** (BPd vs. PVd)[9], ambos publicados en 2024 en *The New England Journal of Medicine*, las combinaciones de belantamab mafodotina (BVd y BPd) obtuvieron aprobación de la EMA para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple desde la primera recaída[10]:

- en combinación con bortezomib y dexametasona (BVd) en pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo, y
- en combinación con pomalidomida y dexametasona (BPd) en pacientes que han recibido al menos un tratamiento previo incluyendo lenalidomida.

Guía Europea EHA-EMN de Mieloma Múltiple

Las guías clínicas europeas (EHA-EMN 2025) recomiendan las combinaciones de belantamab mafodotina (BVd/BPd) para el tratamiento de todos los pacientes con MM desde la primera recaída, independientemente de su tratamiento previo (sensibilidad o refractariedad a anti-CD38, lenalidomida y/o bortezomib) o estado funcional[12] (Figura 2).

Figura 2: **Recomendaciones para el tratamiento del MM en recaída/ refractario desde primera recaída. Guías EHA-EMN 2025**[12]



*Únicamente en pacientes expuestos a lenalidomida.

Figura adaptada de: Dimopoulus, M. et al. Nat Rev Clin Oncol. 2025[12].

2L: segunda línea; **B:** belantamab mafodotina; **borte:** bortezomib; **CD38:** *cluster of differentiation 38*; **cilta-cel:** ciltacabtagene autoleucel; **D:** daratumumab; **d:** dexametasona; **Elo:** elotuzumab; **EHA:** *European Hematology Association*; **EMN:** *European Myeloma Network*; **Isa:** isatuximab; **Ixa:** ixazomib; **K:** carfilzomib; **Len:** lenalidomida; **P:** pomalidomida; **R:** lenalidomida; **S:** Selinexor; **V:** bortezomib.

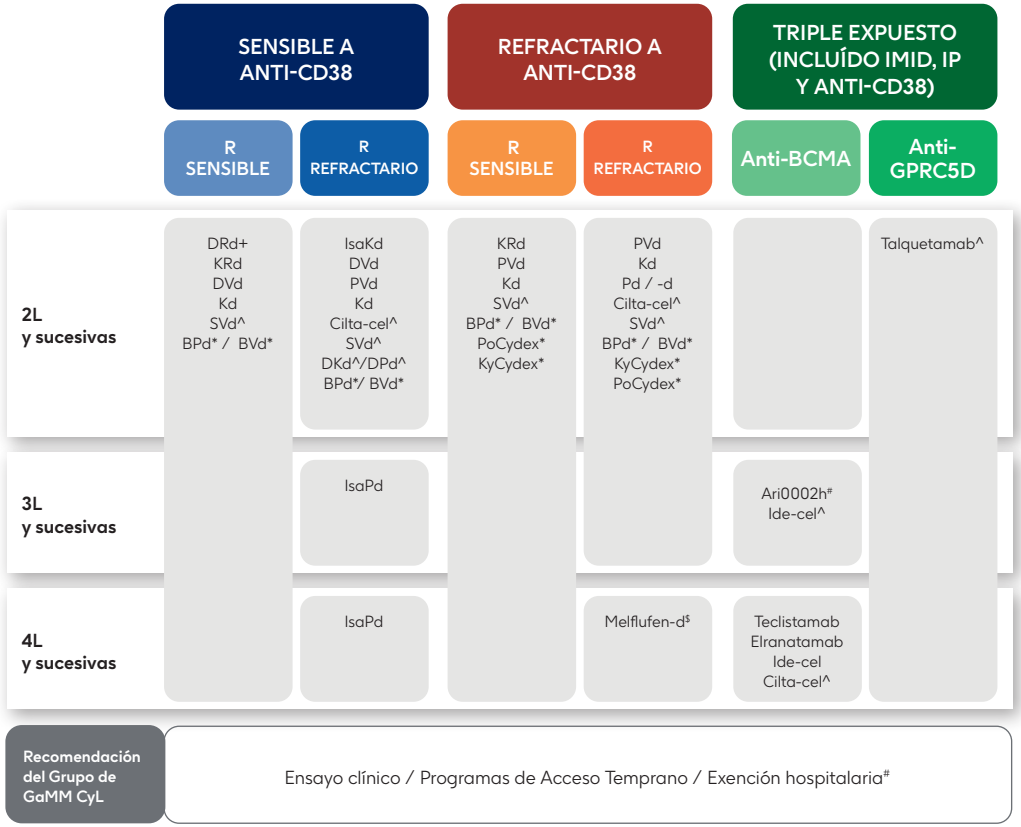
Guía Nacional del Grupo Español de Mieloma (GEM)

El Grupo Español de Mieloma (GEM) publicó la actualización de la guía de mieloma múltiple en 2025 y en ella comentan que las combinaciones de belantamab mafodotina son dos nuevas opciones basadas en terapia dirigida contra BCMA en pacientes en recaída tras, al menos, una línea previa[13].

Hematoguía de MM de Castilla y León

El Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León (GaMM CyL) incluyó en junio de 2024 en la Hematoguía de MiELOMA las combinaciones de belantamab mafodotina para el tratamiento de los pacientes con MM desde la primera recaída que son expuestos y/o refractarios a lenalidomida y/o a anti-CD38[14] (Figura 3).

Figura 3: **Recomendaciones de tratamiento del Mieloma Múltiple en Recaída / Refractario del Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León. 2024**



+ Priorización avalada por el Grupo Cooperativo para el Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León

^ Consultar estado de Financiación en MSCBS (Ministerio de Sanidad - Profesionales de la Salud - Buscador situación financiación medicamentos)

$ Si TAPH previo, el tiempo transcurrido hasta la progresión deberá ser de al menos 3 años desde el transplante

***** No aprobado en ficha técnica

Ari0002h en proceso de exención hospitalaria

#L:# línea de tratamiento; **B:** belantamab mafodotina; **borte:** bortezomib; **CD38:** cluster of differentiation 38; **cilta-cel:** ciltacabtagene autoleucel; **D:** daratumumab; **d:** dexametasona; **GaMMCyL:** Gammapatías Monoclonales de Castilla y León; **Ide-cel:** idecabtagén vicleucel; **Isa:** isatuximab; **K:** carfilzomib; **KyCydex:** carfilzomib + ciclofosfamida + dexametasona ; **P:** pomalidomida; **PoCydex:** pomalidomida + ciclofosfamida + dexametasona; **R:** lenalidomida; **S:** Selinexor; **V:** bortezomib.

Figura adaptada de: Hematoguía MiELOMA Versión 5.2. 2024[14].

Antes de utilizar belantamab mafodotina

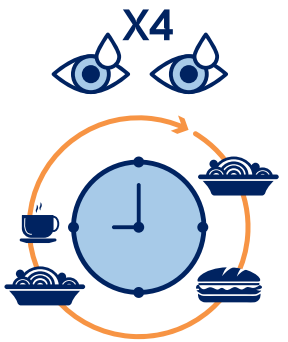
4

Contraindicaciones

No existe ninguna contraindicación para el uso de belantamab mafodotina, **excepto la hipersensibilidad** al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos[10].

Medidas de soporte

- **No es necesaria profilaxis anti-infecciosa específica para belantamab mafodotina[10].**
- **No se requiere pre-medicación** para la perfusión IV (para más información, consultar la sección Reacciones infusionales)[10].
- La administración se realiza de forma **ambulatoria**, mediante perfusión intravenosa (IV), durante aproximadamente **30 minutos**[10].
- **No requiere hospitalización**[10].
- Cuando se **explique el tratamiento al paciente**, se recomienda informarle de que puede experimentar síntomas oculares como por ejemplo **visión borrosa y sequedad ocular**, pero estos son **reversibles, transitorios y manejables con modificaciones de dosis.**
  - La **primera dosis** de inducción de belantamab mafodotina **a 2,5 mg/kg,** necesaria **para alcanzar una respuesta lo antes posible,** puede ocasionar síntomas oculares más intensos, que aparecen en las semanas siguientes a la infusión. Estos síntomas pueden ir desapareciendo poco a poco y, en ocasiones, es necesario retrasar la siguiente administración hasta su recuperación.
  - En el **siguiente ciclo**, los síntomas oculares pueden ser menos intensos porque se administra una **dosis reducida (1,9 mg/kg).**
  - En caso de que los eventos oculares reaparezcan con la dosis reducida (aunque los síntomas sean menos intensos), tras la recuperación, se puede administrar belantamab mafodotina en **ciclos alternos** a **dosis reducida (1,9 mg/kg)**, para dar tiempo suficiente a que el epitelio corneal se regenere entre administraciones.
  - Es importante informar al paciente de que en los ensayos clínicos la **respuesta al tratamiento se mantuvo, o incluso mejoró con estas reducciones de dosis y extensiones en el intervalo entre infusiones**[10, 15].
- Se debe informar al paciente de que se recomienda la administración de **lágrimas artificiales sin conservantes** al menos **4 veces al día en ambos ojos** durante todo el tratamiento[10] (desayuno, comida, merienda, cena). Este uso continuo como profilaxis, permitirá cubrir la alta incidencia de ojo seco que pueden tener los pacientes sin historia previa conocida (afectación infradiagnosticada).

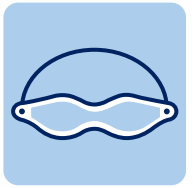


- Se recomiendan **lágrimas artificiales multidosis sin conservantes**[10]



Ha de advertir a los pacientes que utilicen lágrimas artificiales monodosis de la importancia de no reutilizar estos envases para evitar infecciones.

- Es recomendable utilizar **máscara de gel frío** durante la administración del fármaco, con la finalidad de reducir la concentración corneal del mismo por el efecto **vasoconstrictor**[16].



Para más información sobre la profilaxis y recomendaciones para el paciente puede consultar el material del Programa de Soporte a Pacientes (PSP) para hematología y oftalmología en el siguiente QR:

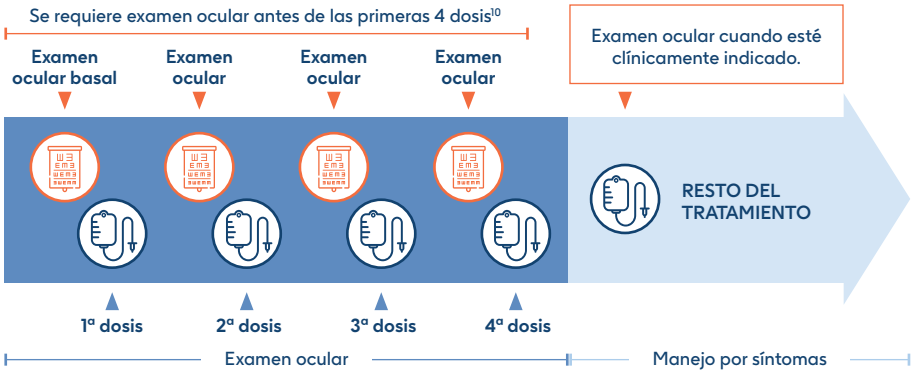
Examen ocular previo a la infusión

Se debe realizar un examen ocular al paciente **antes de cada una de las primeras 4 dosis del tratamiento** con belantamab mafodotina[10].

La evaluación ocular basal no debe retrasar el inicio del tratamiento[17].

En situaciones en las que el examen ocular pudiera retrasar el inicio del tratamiento o el paciente esté progresando rápidamente, el tratamiento debe iniciarse y la evaluación ocular se realizará tan pronto como sea posible[17].

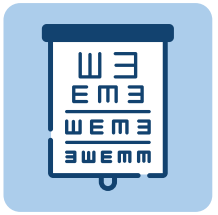
Figura 4: **Exámenes oculares durante el tratamiento con belantamab mafodotina**



Los exámenes oculares antes de la administración de cada una de las cuatro primeras dosis permiten realizar un seguimiento de cada paciente y, en caso de que sea necesario, ajustar la dosis de belantamab mafodotina para **minimizar los posibles eventos oculares manteniendo la eficacia.** Tras estas 4 dosis iniciales, el examen ocular se llevará a cabo **cuando esté clínicamente indicado**. El **hematólogo** puede realizar el **seguimiento de los síntomas oculares del paciente** y derivar a oftalmología en caso necesario[10].

El **examen ocular** incluye:

- evaluación de la **agudeza visual**.
  Permite evaluar la capacidad para distinguir detalles concretos con y sin gafas graduadas.





Si el paciente lleva gafas graduadas, debe llevarlas durante la evaluación.

- examen de la superficie de la córnea con **lámpara de hendidura** para identificar cualquier cambio en el epitelio corneal.



Son procedimientos no invasivos, sencillos y rutinarios.

Pueden realizarse en cualquier consulta de oftalmología en menos de 10 minutos, sin requerir médicos especializados en córnea.

RECOMENDACIONES SOBRE EL EXAMEN Y LA MONITORIZACIÓN OCULAR:

- Es aconsejable que la evaluación de la agudeza visual sea realizada siempre por la misma persona para evitar variabilidad en las mediciones.
- Se recomienda anotar **en la historia clínica del paciente el grado del evento ocular según la escala KVA** para que el hematólogo pueda tomar la decisión sobre la modificación de dosis de belantamab mafodotina.

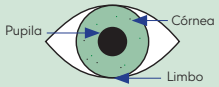
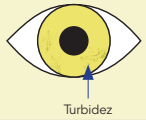
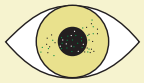
Figura 5. **Escala KVA (Keratopathy and Visual Acuity)**[10]

Escala KVA (Keratopathy and Visual Acuity)[10]

Identifique el grado KVA del evento ocular en la historia clínica del paciente para informar al hematólogo

Continua al mismo nivel de dosis

El hematólogo decidirá la modificación de dosis necesaria para el paciente

GRADO DE SEVERIDAD*	CAMBIOS EN LA AGUDEZA VISUAL: TEST DE SNELLEN	HALLAZGOS CORNEALES: LÁMPARA DE HENDIDURA	REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA E IMÁGENES DE LOS HALLAZGOS CORNEALES	
			Microquistes epiteliales (MECs) y queratopatía punteada superficial	Turbidez subepitelial u opacidad estromal
G1	Disminución de 1 línea desde la evaluación basal	Queratopatía punteada superficial leve con empeoramiento desde el inicio, con o sin síntomas		
G2	Disminución de 2 líneas desde la evaluación basal (y una agudeza visual ≥ 20/200)	Queratopatía punteada superficial moderada, depósitos similares a microquistes parcheados, turbidez subepitelial periférica o una nueva opacidad del estroma periférico	PERIFÉRICO/PARACENTRAL  Los puntos negros representan MECs y los verdes tinción con fluoreceina	PERIFÉRICO/PARACENTRAL 
G3	Disminución de 3 o más líneas desde la evaluación basal (y una agudeza visual ≥ 20/200)	Queratopatía punteada superficial grave, depósitos similares a microquistes difusos involucrando la parte central de la córnea, turbidez subepitelial central o una nueva opacidad del estroma central	CENTRAL 	CENTRAL 
G4	Disminución de la agudeza visual < 20/200	Defecto epitelial persistente, como úlceras corneales		

* La gradación del evento ocular se define por el ojo más gravemente afectado, ya que ambos ojos pueden no estar afectados en el mismo grado.

10. Ficha técnica Blenrep (belantamab mafodotina). Titular de la autorización de comercialización GSK.

- Para más información sobre cómo identificar y gradar los eventos oculares consulte el Atlas oftalmológico en el siguiente QR.
- En caso de identificarse un evento ocular es esencial que exista una buena comunicación entre oftalmología y hematología.
- Muchos pacientes con mieloma múltiple pueden desarrollar **cataratas** por el tratamiento continuo con corticoides y por la edad avanzada.
  - Es importante que, si en el **examen ocular basal** se identifica que el paciente tiene cataratas, **se realice el cálculo de la lente.** Si no se pudo calcular en el momento basal, debe hacerse cuando la córnea esté estable (si se calcula la lente con afectación de la córnea, al resolverse, la graduación de la lente no será la adecuada).
  - **La cirugía de cataratas puede realizarse durante el tratamiento con belantamab mafodotina** y se debe personalizar el momento, sin retrasar el inicio de tratamiento.
  - Tras la cirugía se debe manejar la superficie ocular con colirios sin conservantes y realizar un seguimiento estrecho.

Citación para el examen ocular

Con la indicación y necesidad actual, el paciente con mieloma múltiple en tratamiento con belantamab mafodotina debe considerarse **preferente** y, dar a conocer esta circunstancia, es importante para así conseguir la máxima colaboración con la **programación de citas para los exámenes oculares**.

RECOMENDACIONES PARA EL HEMATÓLOGO:

- Dar a conocer la condición de **paciente preferente en la programación de citas para los exámenes oculares**.
- Citar al paciente para la **evaluación basal ocular lo antes posible**.
- **Comunicar la fecha prevista de la siguiente dosis** para dejar programado el siguiente examen ocular.

Posología belantamab mafodotina en combinación

5

Al iniciar el tratamiento en recaída, la **dosis inicial de belantamab mafodotina ha de ser 2,5 mg/kg para conseguir una respuesta lo antes posible,** independientemente de la combinación a utilizar.

El tiempo hasta la respuesta con las combinaciones de belantamab mafodotina es rápido, la respuesta suele ocurrir en un mes y medio desde la primera infusión[6].

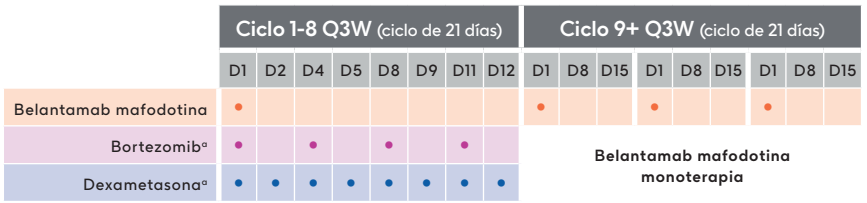
Belantamab mafodotina se dosifica en función del peso corporal real y ha sido estudiado en pacientes con peso corporal de 37 a 170 kg[10].

Para **cambios en el peso corporal de >10%** durante el tratamiento, **recalcular la dosis** en función del peso corporal real en el momento de la dosificación[10].

Figura 6. **Posología inicial BVd**[10]

Régimen de combinación	Pauta posológica inicial de belantamab mafodotina
Con bortezomib y dexametasona (BVd)[a] (Duración del ciclo = 21 días)	2,5 mg/kg administrados una vez cada 3 semanas

FICHA TÉCNICA



[a] Bortezomib y dexametasona se administran únicamente durante los primeros 8 ciclos

C: ciclo; **D:** día; **IV:** intravenoso; **Q3W:** cada 3 semanas.

- Belantamab mafodotina IV 2,5 mg/kg
- Bortezomib 1,3 mg/m², días 1, 4, 8, 11
- Dexametasona 20 mg (el día de borte y el posterior)

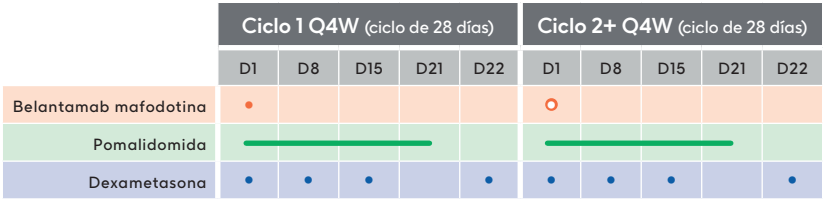
La administración de belantamab mafodotina debe continuar según la pauta posológica recomendada hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Los medicamentos que se administran con belantamab mafodotina en combinación siguen la siguiente pauta (consultar la Ficha Técnica vigente del producto correspondiente):

- Bortezomib y dexametasona se administran únicamente durante los 8 primeros ciclos en la combinación BVd.
- Pomalidomida y dexametasona se administran de manera continua hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable en la combinación BPd.

Figura 7. **Posología inicial BPd**[10]

Régimen de combinación	Pauta posológica inicial de belantamab mafodotina
Con pomalidomida y dexametasona (BPd) (Duración del ciclo = 28 días)	• **Ciclo 1:** 2,5 mg/kg administrados una vez • **A partir del Ciclo 2:** 1,9 mg/kg administrados una vez cada 4 semanas

FICHA TÉCNICA



C: ciclo; **D:** día; **IV:** intravenoso; **PO:** vía oral; **Q4W:** cada 4 semanas.

- Belantamab mafodotina IV 2,5 mg/kg
- Belantamab mafodotina IV **1,9 mg/kg**
- Pomalidomida 4 mg PO, días 1-21
- Dexametasona 40 mg, días 1, 8, 15 y 22

Ajuste de dosis de belantamab mafodotina durante el seguimiento:

En los pacientes que tengan eventos adversos, se debe modificar la dosis para manejarlos. Durante los ensayos clínicos DREAMM-7[6] y DREAMM-8[9] tras la primera dosis de belantamab mafodotina a 2,5 mg/kg, la primera modificación de **dosis fue reducir a 1,9 mg/kg**. Si el paciente necesitaba una **modificación de dosis adicional**, se pautaba **belantamab mafodotina** (1,9 mg/kg) **en ciclos alternos**, para **aumentar el intervalo entre dosis** (cada 6 semanas para BVd o cada 8 semanas para BPd).

La **respuesta al tratamiento se mantuvo o incluso mejoró** en los pacientes en los que se redujo la dosis y se aumentó el intervalo entre dosis[15].

En los ensayos clínicos se describen modificaciones de algún tipo por eventos adversos en el 98% de pacientes del DREAMM-7 y en el 95% de pacientes del DREAMM-8[18]. En estos pacientes, a partir de los 9 meses, la administración se realizó con un intervalo (mediana) de 8 y 12 semanas, respectivamente[15].

Tabla 1: **Intervalo entre dosis de belantamab mafodotina observadas en los EECC**[15]

Mediana de intervalo entre dosis en los ensayos clínicos	DREAMM-7 BVd	DREAMM-8 BPd
Pacientes que llevaban de tres a seis meses en tratamiento	6 semanas	8 semanas
Pacientes que llevaban más de nueve meses en tratamiento	8 semanas	12 semanas

Poblaciones especiales

No es necesario un ajuste de la dosis inicial para pacientes:

- **Mayores de 65 años**[10]
- Con **insuficiencia renal**[10]
- Con **insuficiencia hepática leve**[10]*****

*****Los datos en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave son limitados para apoyar una recomendación de dosis. En estos casos, belantamab mafodotina puede considerarse solo si el beneficio potencial supera el riesgo, aplicando una estricta monitorización clínica.

Reacciones adversas y su manejo

Trombocitopenia

Se notificó trombocitopenia de cualquier grado en el 74% de los pacientes incluidos en los ensayos DREAMM-6, -7 y -8 (Grado 2, 10%; Grado 3, 26% y Grado 4, 33%)[10], que compartían el criterio de inclusión de recuento de plaquetas ≥ 75 × 10⁹/L.

No hay ninguna contraindicación para el uso de belantamab mafodotina basada en el recuento de plaquetas, pudiendo iniciarse a dosis plenas[10]. Consultar la ficha técnica de bortezomib y pomalidomida para ver las recomendaciones en esta situación.

RECOMENDACIONES DURANTE EL TRATAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE DOSIS:

- Monitorización frecuente (mensual) mediante **hemogramas completos** con diferencial, incluyendo recuentos de plaquetas[10].

  En caso de **trombocitopenia como reacción adversa Grado 3 o 4 o en aquellos pacientes con un tratamiento anticoagulante concomitante:**

  - Se puede requerir una **monitorización más frecuente**, y deben ser manejados con modificaciones de la dosis según la figura 8[10].
  - El tratamiento de soporte (por ejemplo, transfusiones de plaquetas) se debe proporcionar de acuerdo con la práctica clínica habitual.

Figura 8. **Modificaciones de la dosis de belantamab mafodotina recomendadas para el manejo de la trombocitopenia como reacción adversa**[10]

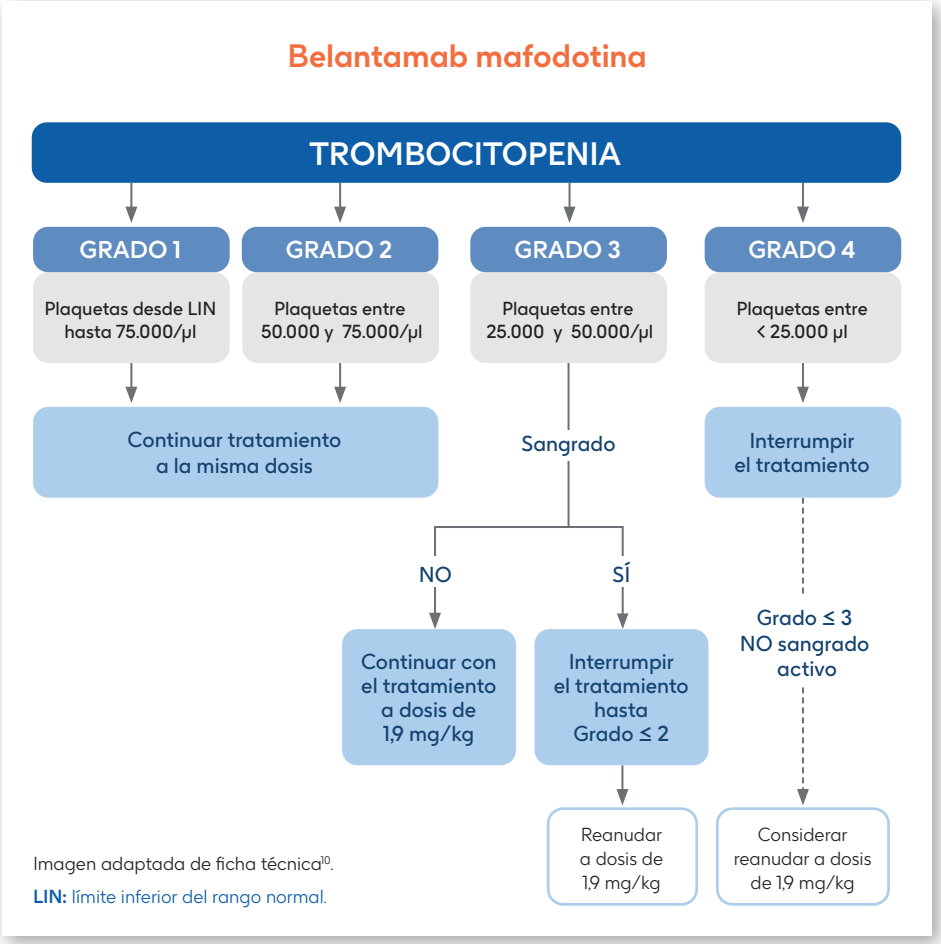


Imagen adaptada de ficha técnica[10].

LIN: límite inferior del rango normal.

Reacciones infusionales

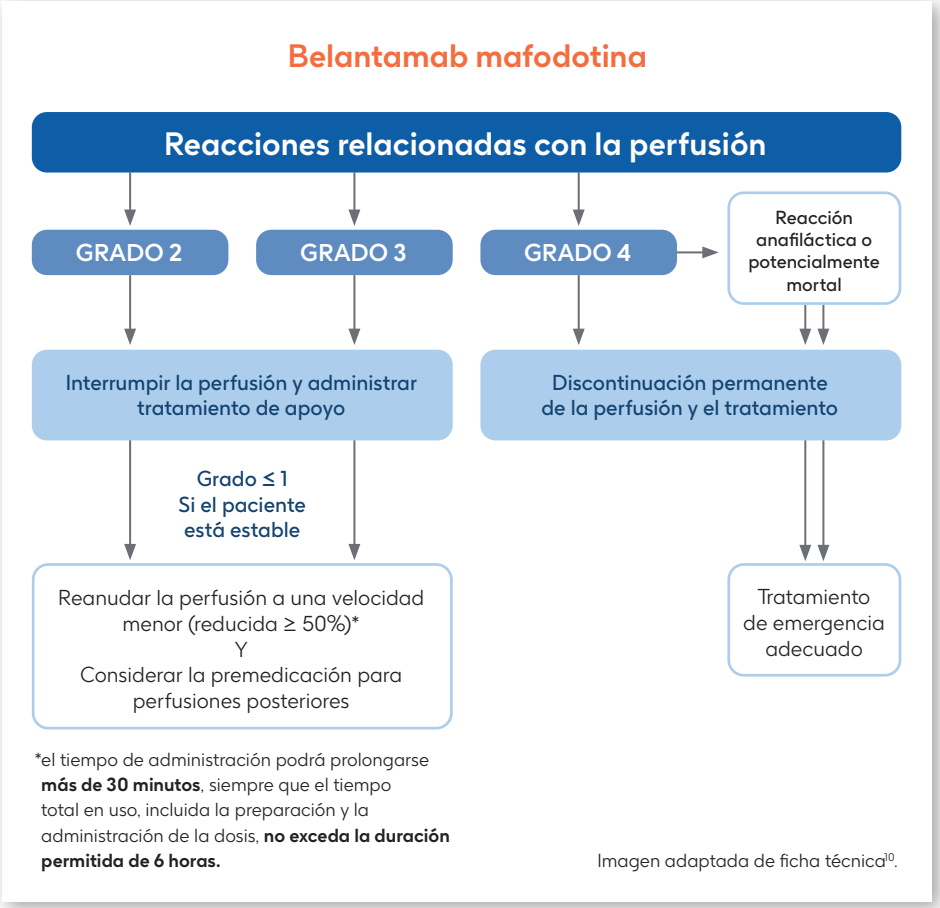
No se requiere premedicación para la perfusión IV. Únicamente se considera premedicación para la perfusión en caso de que el paciente haya experimentado una reacción relacionada con la perfusión previa.

Se han notificado reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) con el uso de belantamab mafodotina en el **6% de los pacientes** de los ensayos DREAMM-6, -7 y -8[10]. Estas fueron de **grado 1 (2%), grado 2 (4%) y grado 3 (<1%)** y se resolvieron en el mismo día. La mayoría de las RRPs (4%) sucedieron durante la primera perfusión[10].

Estas RRPs pueden incluir, entre otras, pirexia, escalofríos, diarrea, náuseas, astenia, hipertensión, letargo y taquicardia[10].

Si se produce una reacción relacionada con la perfusión de Grado 2 o mayor durante la administración, se debe reducir la velocidad de perfusión o interrumpir la perfusión en función de la gravedad de los síntomas y proporcionar el tratamiento médico apropiado según la figura 9.

Figura 9. **Manejo de las reacciones infusionales durante el tratamiento**[10]



En caso de RRP Grado ≥ 2 en alguna perfusión, utilizar la premedicación recomendada por práctica clínica en su hospital para las perfusiones subsiguientes.

Neumonitis

Menos del 1% de los pacientes con MM tratados con belantamab mafodotina experimentaron neumonitis (de cualquier grado)[10]. En el caso de **neumonitis Grado ≥3** se debe **discontinuar permanentemente** belantamab mafodotina[10].

Eventos oculares

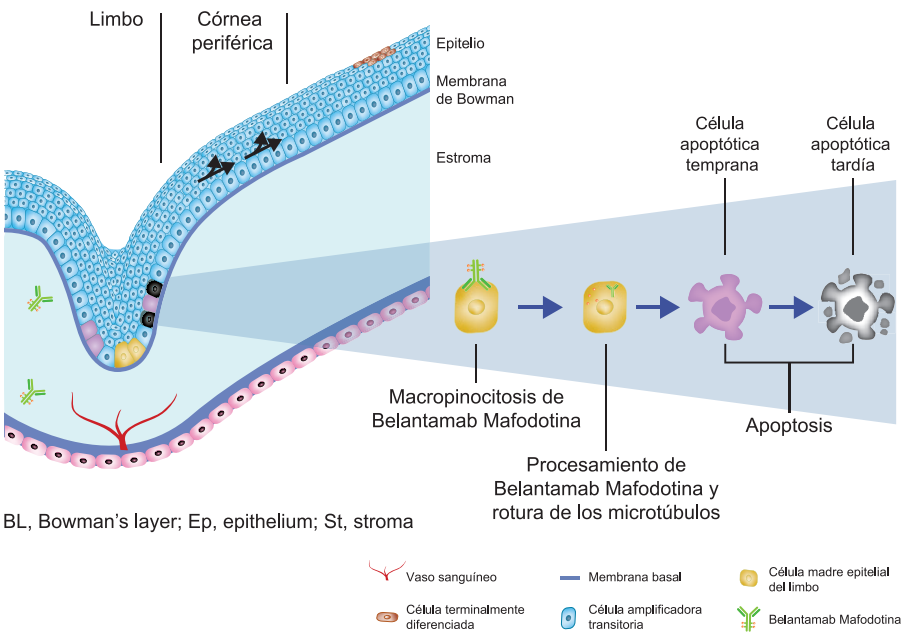
No existen contraindicaciones por condiciones previas oculares que impidan recibir tratamiento con las combinaciones de belantamab mafodotina. La presencia de cualquier condición ocular basal (cataratas, queratopatía, ojo seco, glaucoma, blefaritis, degeneración macular y retinopatía diabética) no aumentó la incidencia de eventos oculares [17, 19].

La enfermedad de ojo seco, como cualquier otra condición ocular previa, no contraindica el uso de belantamab mafodotina y debe ser manejada durante el tratamiento como se haría en cualquier otro paciente.

Mecanismo por el que aparecen los eventos oculares

Los eventos oculares relacionados con belantamab mafodotina ocurren en el epitelio corneal (capa más externa de la córnea que se regenera continuamente). Son consecuencia de la internalización del agente citotóxico, mafodotina, en las células del epitelio corneal, lo que puede provocar la muerte por apoptosis de estas células y/o la formación de quistes en el epitelio. Las células afectadas migran desde la periferia hacia el centro de la córnea (eje visual), pudiendo producir cambios en la visión y **síntomas como visión borrosa o sequedad ocular.** Debido a que el **epitelio corneal se regenera de forma natural** (en aproximadamente 20 días [14-90 días][20]), estos eventos oculares son reversibles con modificaciones de dosis y extensiones en el intervalo entre dosis[21].

Figura 10. **Representación del tejido epitelial y el proceso de regeneración constante**



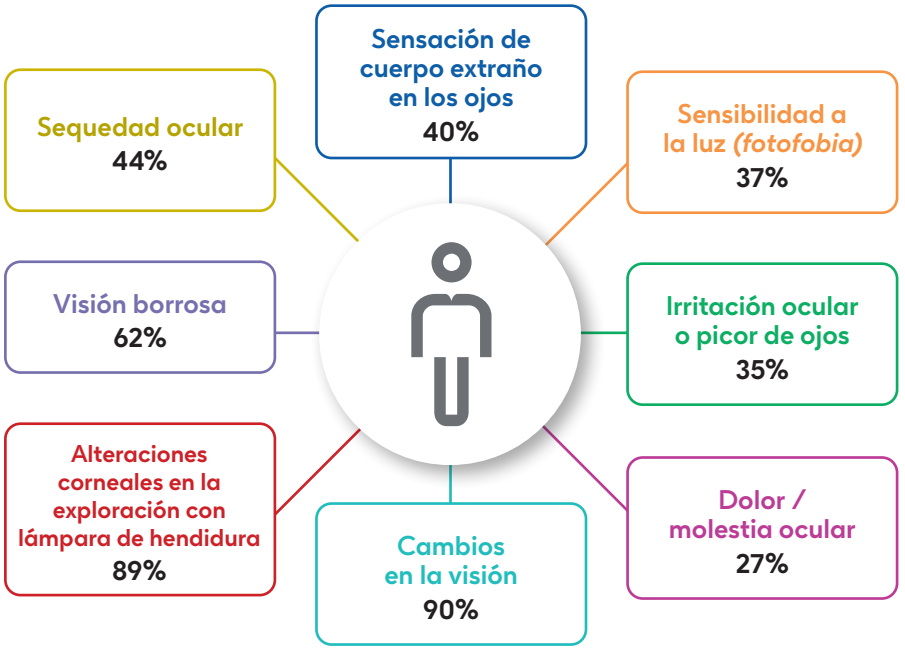
BL, Bowman's layer; Ep, epithelium; St, stroma

Imagen adaptada de Farooq AV, et al. Ophthalmol Ther 2020[21]

Posibles síntomas oculares asociados a belantamab mafodotina

En los ensayos clínicos, los eventos oculares más frecuentes (>25%) fueron (Figura 11): cambios en la visión (90%), alteraciones corneales en la exploración con lámpara de hendidura (89%), visión borrosa (62%), sequedad ocular (44%), sensación de cuerpo extraño en los ojos (40%), fotofobia (37%), irritación ocular (35%) y dolor ocular (27%). No todos estos eventos oculares se **traducen en síntomas que impacten en las actividades diarias del paciente**[10].

Figura 11. **Posibles síntomas oculares relacionados con belantamab mafodotina.**



Los eventos oculares son **reversibles**, transitorios y manejables con reducciones y extensiones en el intervalo entre dosis[6, 9, 15, 17].

De los pacientes que en los ensayos clínicos DREAMM-7 y DREAMM-8 partían de una visión normal (89%)[15], **el 62% no experimentaron cambios en la visión que impactaran en sus actividades diarias (ej. conducir, leer)**[15, 22]. En la figura 12 se representan los cambios en la mejor agudeza visual corregida (BCVA, por sus siglas en inglés) experimentados por dichos pacientes.

Figura 12. **Cambios en la visión/mejor agudeza visual corregida (BCVA, por sus siglas en inglés) en los pacientes con BCVA normal (89%) al inicio de los EECC DREAMM-7 y DREAMM-8**

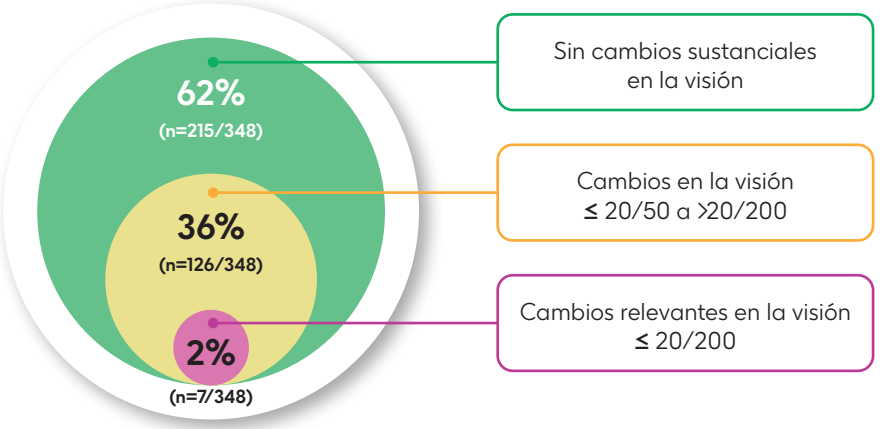


Figura adaptada de Hayek R, et al. Poster PS1761[23] presentado en el congreso de la EHA 2025.

Con permiso de la EHA y los autores .®2025. los autores. Todos los derechos reservados.

Grado de los eventos oculares

Se debe realizar un examen ocular a los pacientes **antes de cada una de las primeras 4 dosis del tratamiento** con belantamab mafodotina y, **durante el tratamiento, cuando esté clínicamente indicado**[10].

Tras el examen ocular, al que el paciente tendrá que asistir con sus gafas graduadas si las tiene, el oftalmólogo (o profesional de la salud ocular), ha de comunicar al hematólogo en la historia clínica del paciente el **grado del evento** ocular (G1, 2, 3 o 4) del ojo más afectado, según la escala ***Keratopathy and Visual Acuity* (KVA)**[7, 8]. Es importante mantener una comunicación efectiva entre hematología y oftalmología porque en ciertos momentos habrá que tener en cuenta el balance entre la importancia de la dosis concreta en el tratamiento del mieloma múltiple y el riesgo real ocular teniendo en cuenta que el epitelio corneal se regenera con el tiempo.

Figura 13. **Escala KVA (Keratopathy and Visual Acuity)**[10]

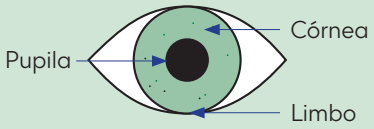
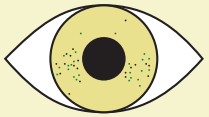
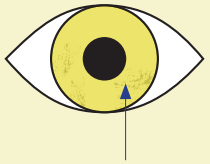
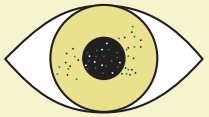
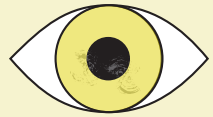
Identifique el grado KVA del evento ocular en la historia clínica del paciente para informar al hematólogo



Se deben realizar todos los exámenes oculares con las gafas habituales de los pacientes

Continua al mismo nivel de dosis

El hematólogo decidirá la modificación de dosis necesaria para el paciente

GRADO DE SEVERIDAD*	CAMBIOS EN LA AGUDEZA VISUAL: TEST DE SNELLEN	HALLAZGOS CORNEALES: LÁMPARA DE HENDIDURA	REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA E IMÁGENES DE LOS HALLAZGOS CORNEALES	
			Microquistes epiteliales (MECs) y queratopatía punteada superficial	**Turbidez subepitelial u opacidad estromal**
G1	Disminución de 1 línea desde la evaluación basal	Queratopatía punteada superficial leve con empeoramiento desde el inicio, con o sin síntomas		
G2	Disminución de 2 líneas desde la evaluación basal (y una agudeza visual ≥ 20/200)	Queratopatía punteada superficial moderada, depósitos similares a microquistes parcheados, turbidez subepitelial periférica o una nueva opacidad del estroma periférico	PERIFÉRICO/PARACENTRAL  Los puntos negros representan MECs y los verdes tinción con fluoreceina	PERIFÉRICO/PARACENTRAL 
G3	Disminución de 3 o más líneas desde la evaluación basal (y una agudeza visual ≥ 20/200)	Queratopatía punteada superficial grave, depósitos similares a microquistes difusos involucrando la parte central de la córnea, turbidez subepitelial central o una nueva opacidad del estroma central	CENTRAL 	CENTRAL 
G4	Disminución de la agudeza visual < 20/200	Defecto epitelial persistente, como úlceras corneales		

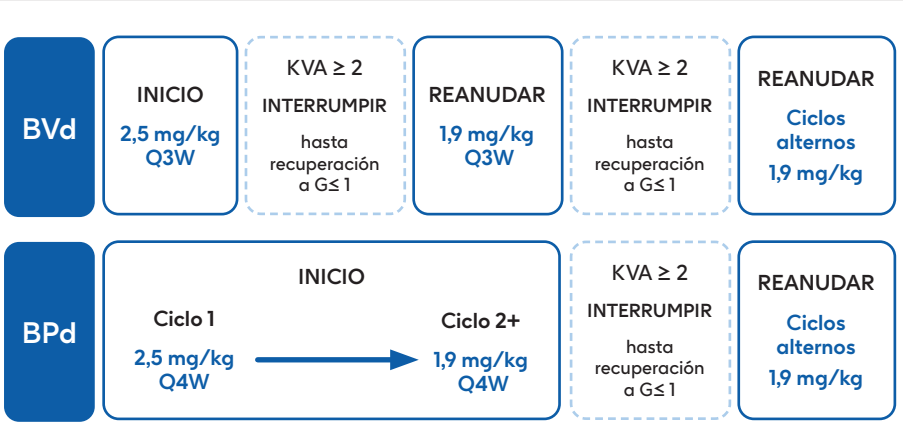
* La gradación del evento ocular se define por el ojo más gravemente afectado, ya que ambos ojos pueden no estar afectados en el mismo grado.

Con la información sobre el grado según la escala KVA que proporciona el profesional de la salud ocular, el hematólogo decide la posible modificación de dosis necesaria para el paciente[24].

Los datos de los ensayos sugieren que los eventos oculares de grado 4 según la escala KVA son **poco frecuentes** en pacientes tratados con belantamab mafodotina[17].

Para más información sobre los tipos de eventos oculares, como identificarlos y gradarlos, puede consultar el atlas oftalmológico en este QR.

Figura 14. **Recomendaciones sobre las modificaciones de dosis de belantamab mafodotina**[10]



G: grado; **KVA:** *Keratopathy and Visual Acuity*; **Q#W:** cada # semanas.

RECOMENDACIONES SOBRE LA MODIFICACIÓN DE DOSIS DE BELANTAMAB MAFODOTINA

- Los pacientes en recaída deben iniciar el tratamiento con **belantamab mafodotina a dosis de 2,5 mg/kg** para conseguir una respuesta lo antes posible (Figura 14).
- Cuando un paciente tiene un evento ocular relacionado únicamente con belantamab mafodotina **KVA ≥ grado 2, debe interrumpir** la dosis de belantamab mafodotina **hasta recuperación** a KVA ≤ grado 1 (Figura 14).
- Cuando se interrumpe el tratamiento por un evento ocular sólo relacionado con belantamab mafodotina, **el resto de los tratamientos de la combinación deben mantenerse a dosis estándar (Vd o Pd).**
- Una vez recuperado, se debe **reintroducir belantamab mafodotina a una dosis de 1,9 mg/kg** (Figura 14).
- Si a la dosis de 1,9 mg/kg vuelve a experimentar un evento ocular KVA ≥ grado 2 debe interrumpirse la dosis hasta recuperación a KVA ≤ grado 1 (Figura 14).
- Una vez recuperado, se puede **extender el intervalo entre dosis utilizando belantamab mafodotina en ciclos alternos.**
- Cuando se realiza una modificación de la dosis por un evento ocular **no se debe volver a la dosis o intervalo anterior** (Figura 14).
- Durante las extensiones del intervalo entre dosis los pacientes **mantuvieron o profundizaron la respuesta**, incluso con intervalos de hasta 12 semanas en los ensayos DREAMM-7 y DREAMM-8[15].

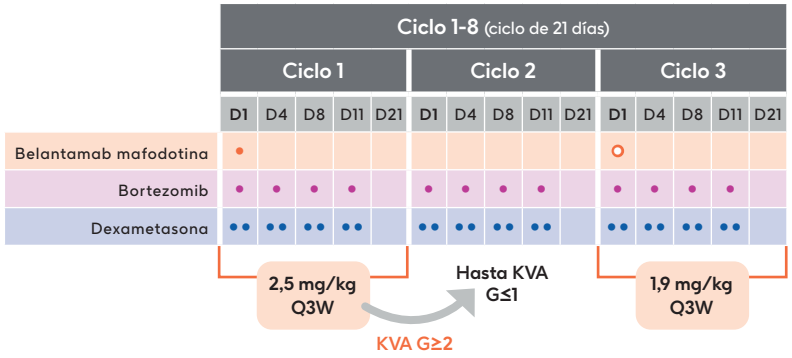
En las siguientes figuras se recogen las modificaciones de belantamab mafodotina requeridas en presencia de eventos oculares Grado ≥ 2 (según escala KVA) basadas en la evidencia de las extensiones que tuvieron lugar en los ensayos[6, 9, 12, 15].

Ejemplo 1- BVd (Figura 15)

- El paciente está en tratamiento con BVd y en el ciclo 1 recibe la dosis de 2,5 mg/kg.
- En el examen ocular previo al ciclo 2, el paciente tiene un evento ocular G2, por lo que en el ciclo 2 no recibe belantamab mafodotina, pero continúa recibiendo bortezomib y dexametasona a dosis estándar.
- Antes del ciclo 3 el paciente tiene la revisión ocular y ha recuperado el evento ocular a G1, por lo que puede recibir el siguiente ciclo de belantamab mafodotina a una dosis reducida de 1,9 mg/kg Q3W.

Figura 15: **Ejemplo 1 de espaciado de dosis según la evidencia del DREAMM-7 (BVd)**

EJEMPLO 1 DE ESPACIADO DE DOSIS SEGÚN LA EVIDENCIA DEL DREAMM-7 (BVd)



BVd: belantamab mafodotina, bortezomib, dexametasona; **Borte:** bortezomib; **dexa:** dexametasona; **G:** grado; **Q#W:** cada # semanas; **KVA:** *Keratopathy and Visual Acuity.*

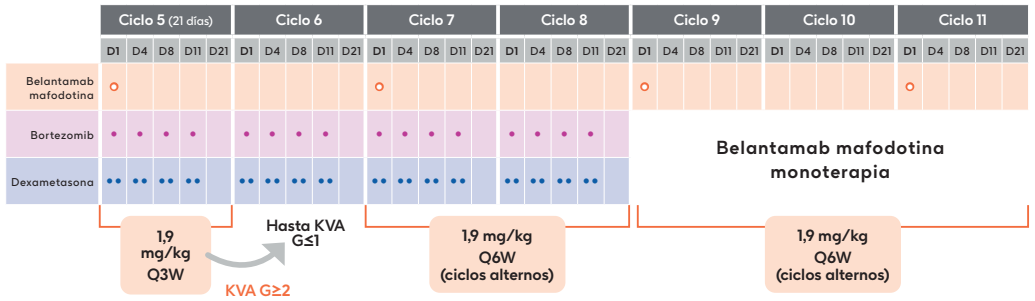
- Belantamab mafodotina IV **2,5 mg/kg**
- Belantamab mafodotina IV **1,9 mg/kg**
- Borte 1,3 mg/m², días 1, 4, 8, 11
- Dexa **20** mg (el día de borte y el posterior)

Ejemplo 2- BVd (Figura 16)

- El paciente está en tratamiento con BVd y en el ciclo 5 se encuentra a la dosis de 1,9 mg/kg Q3W.
- Antes de recibir el ciclo 6, el paciente le comunica al hematólogo que tiene visión borrosa y le impacta bastante en las actividades de su vida diaria. El hematólogo deriva al paciente al oftalmólogo para realizar el examen ocular y se detecta un evento ocular G2, por lo que en el ciclo 6 no recibe belantamab mafodotina y continúa con bortezomib y dexametasona.
- Antes del ciclo 7 el paciente tiene la revisión ocular y observa que el paciente se ha recuperado a G1, por lo que puede recibir el siguiente ciclo de belantamab mafodotina a una dosis extendida, en ciclos alternos (1,9 mg/kg cada 6 semanas).

Figura 16: **Ejemplo 2 de espaciado de dosis según la evidencia del DREAMM-7 (BVd)**

EJEMPLO 2 DE ESPACIADO DE DOSIS SEGÚN LA EVIDENCIA DEL DREAMM-7 (BVd)



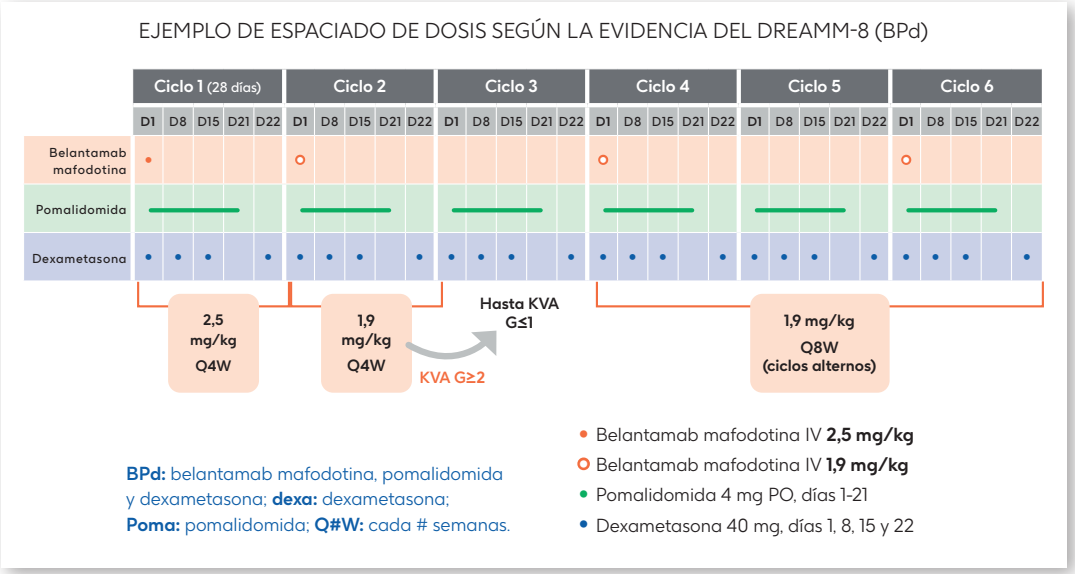
BVd: belantamab mafodotina, bortezomib, dexametasona; **Borte:** bortezomib; **dexa:** dexametasona; **Q#W:** cada # semanas; **KVA:** *Keratopathy and Visual Acuity.*

- Belantamab mafodotina IV **2,5 mg/kg**
- Belantamab mafodotina IV **1,9 mg/kg**
- Borte 1,3 mg/m², días 1, 4, 8, 11
- Dexa **20** mg (el día de borte y el posterior)

Ejemplo 3- BPd (Figura 17)

- El paciente está en tratamiento con BPd, en el ciclo 1 recibe la dosis de 2,5 mg/kg y, en el ciclo 2 a las 4 semanas, la dosis de 1,9 mg/kg.
- En el examen ocular previo al ciclo 3 tiene un evento ocular G2, por lo que en este ciclo no recibe belantamab mafodotina y continúa con pomalidomida y dexametasona.
- Antes del ciclo 4 el paciente tiene la revisión ocular y ha recuperado el evento ocular a G1, por lo que puede recibir el siguiente ciclo de belantamab mafodotina a una dosis extendida, en ciclos alternos (1,9 mg/kg cada 8 semanas).

Figura 17: **Ejemplo 3 de espaciado de dosis según la evidencia del DREAMM-8 (BPd)**



Seguimiento de los eventos oculares por síntomas a partir de la cuarta dosis

Tras la administración de la cuarta dosis de belantamab mafodotina, los posibles síntomas oculares, como visión borrosa o sequedad ocular, pueden ser identificados en la consulta de hematología.

A partir de este momento, la monitorización clínica puede realizarse mediante la valoración dirigida de síntomas. Para ello, se recomienda que el hematólogo formule al paciente las siguientes preguntas orientadas a la detección de eventos oculares[17]:



Si el paciente responde "Bastantes" o "Muchas" en alguna de las dos preguntas y con empeoramiento respecto al anterior o al basal, debe ser derivado al oftalmólogo y, mientras tanto, interrumpir la dosis.

Preguntando al paciente se detectan los eventos relevantes a nivel oftalmológico después de que la dosis ya haya sido ajustada durante las 4 primeras infusiones. La derivación a oftalmología tiene como objetivo identificar si los síntomas oculares que refiere el paciente están relacionados únicamente con belantamab mafodotina e investigar cualquier otra causa.

En aquellos pacientes con afectación ocular basal, como ojo seco, problemas de refracción, cataratas, etc... las respuestas pueden ser "Bastantes" o "Muchas" incluso antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, el que sea el paciente el que responda directamente al hematólogo en la consulta, permite indagar para comparar la situación actual respecto a la visita basal o a las anteriores visitas, e identificar si ha empeorado o se mantiene como antes de iniciar tratamiento.

Información importante para el paciente en tratamiento con belantamab mafodotina:



1. No utilizar lentes de contacto (lentillas) mientras esté en tratamiento con belantamab mafodotina.



2. Utilizar lágrimas artificiales sin conservantes 1 gota en cada ojo al menos 4 veces al día (desayuno, comida, merienda y cena).



3. Traer la máscara de frío refrigerada a su próxima infusión de belantamab mafodotina en el hospital de día.



4. Traer siempre sus gafas graduadas (si tiene) a la consulta de oftalmología.



5. Tener precaución al conducir o manejar maquinaria mientras esté en tratamiento con belantamab mafodotina.



6. Apuntar cualquier síntoma ocular (ej. visión borrosa y sequedad ocular) y comunicarlo al hematólogo y/o oftalmólogo.

Programa de apoyo a pacientes en tratamiento con las combinaciones de belantamab mafodotina

Este programa está diseñado para ayudarle en el seguimiento de su salud ocular y es completamente gratuito para usted. Para registrarse debe llamar al siguiente teléfono:

900 293 857

De lunes a viernes, de 9:00h a 18:00h

EL PROGRAMA LE OFRECE, DE MANERA GRATUITA:

1. Un Kit de inicio de salud ocular que recibirá en su domicilio y que contiene: lágrimas artificiales sin conservantes, máscara de frío, bolsa contenedora con un acumulador de frío e información adicional.
2. Apoyo telefónico por personal de enfermería especializado.
3. Suministro de lágrimas artificiales sin conservantes durante todo su tratamiento.

INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE

Programa de apoyo a pacientes tratados con las combinaciones de belantamab mafodotina

Introducción

Este es un programa de apoyo a pacientes adultos con mieloma múltiple en tratamiento con las combinaciones de belantamab mafodotina (en adelante, "El Programa"). Sin perjuicio del mayor detalle facilitado, el presente programa de apoyo a pacientes se presta a través un centro de atención telefónica formado por un equipo de enfermería entrenado.

Los objetivos del programa son:

1. Optimizar su salud ocular durante el tratamiento, con el fin de prevenir, detectar y controlar cualquier síntoma ocular (ej. visión borrosa y sequedad ocular).
2. Proporcionarle un kit de inicio de salud ocular para ayudarle con las medidas de prevención. El kit contiene, entre otras cosas, lágrimas artificiales sin conservantes y una máscara de gel frío para sus ojos.
3. Resolver sus dudas y realizar un seguimiento telefónico de cualquier cambio en su salud ocular por personal de enfermería especializado, para que pueda sentirse más seguro con su tratamiento.

La pauta de llamadas se establecerá en función de sus preferencias y necesidades clínicas. Y siempre que lo necesite podrá llamar de manera proactiva para resolver sus dudas. Una vez dado de alta, recibirá en 24-72 horas el kit de inicio en su domicilio, motivo por el que se necesita disponer de su dirección personal.

El Programa está financiado por GlaxoSmithKline, S.A (GSK), laboratorio farmacéutico titular del mencionado medicamento y es prestado por una compañía especializada en este tipo de servicios, denominada EVIDENZE HEALTH ESPAÑA S.L.U. No obstante, el laboratorio no tendrá acceso a sus datos personales en ningún momento.

Su participación es voluntaria y quedará confirmada, si así lo decide, con la grabación de su consentimiento durante la llamada de registro. La intención es que usted reciba información adecuada y suficiente para que pueda valorar y decidir si quiere o no participar en este Programa.

¿Cuánto dura el programa? ¿tengo que permanecer en el proyecto?

El Programa le dará soporte mientras este en tratamiento con las combinaciones de belantamab mafodotina. Sin perjuicio de lo anterior, usted puede retirarse del Programa cuando usted quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que ello repercuta en sus cuidados médicos.

¿Qué información personal recopilamos sobre usted? (la información marcada con * es obligatoria para poder participar en el programa)

- Nombre y Apellidos*
- Dirección postal*
- Código postal*
- Provincia*
- Teléfono de contacto*
- NIF – (requerido para envíos a Canarias)
- Acontecimientos adversos
- Centro de referencia

¿Qué ocurre con mis datos personales?

Responsable del Tratamiento: Como hemos explicado anteriormente, GlaxoSmithKline, S.A (GSK) es el laboratorio que financia este Programa y que ha contratado los servicios del proveedor y, aunque no tendrá acceso a los datos personales de los participantes en el programa, es el Responsable de asegurar que se cumpla la normativa de protección de datos en el tratamiento de sus datos personales durante la ejecución del Programa, adoptando las medidas oportunas para ello.

¿Cómo protegemos su información personal?

Queremos asegurarnos de que su información personal no sea compartida o utilizada por aquellos que no estén autorizados para verla.

Elegimos cuidadosamente a nuestros proveedores de servicios y comprobamos que cuenten con medidas y tecnologías de seguridad para proteger su información personal. No permitimos que nuestros proveedores de servicios utilicen su información personal para sus propios fines.

¿Para qué empleamos su información personal?

Los datos personales se tratarán exclusivamente con la finalidad de cumplimiento y gestión del Programa. Se conservarán hasta cinco años después de la finalización del Programa o un plazo superior si así lo estableciesen requisitos legales.

¿Por qué necesitamos recopilar determinada información personal?

El Programa necesita tratar determinados datos personales sobre usted para poder prestarle los servicios (como su dirección postal para enviarle el kit de inicio de salud ocular o su teléfono para poder contactarle para realizar las llamadas de seguimiento). Por tanto, la base jurídica para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento expreso para participar en el Programa y que quedará documentado a través de la grabación de la llamada telefónica de registro.

¿Qué derechos tiene usted con relación a su información personal?

En cualquier momento, y en los términos establecidos en la legislación vigente, podrá solicitar:

- Acceso sobre el tratamiento de su información personal.
- Una copia de su información personal.
- La corrección o eliminación de su información personal.
- Cuando ello resulte posible, la transferencia de su información personal a un tercero en un formato adecuado para su reutilización.

También puede:

- Oponerse al tratamiento de su información personal. En ese caso, advertirle que no podríamos seguir prestándole los servicios del Programa.
- Presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerase que se han infringido sus derechos de privacidad.
- Tener derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos o como consecuencia del tratamiento indebido de su información personal.

Para el ejercicio de tales derechos o informarse sobre los mismos, usted puede dirigirse al proveedor del Programa "EVIDENZE HEALTH ESPAÑA S.L.U", con CIF B-63286280, en la dirección Passatge Ferrer i Vidal nº 8, 08005 (Barcelona) a la atención del Delegado de Protección de Datos o a través de la dirección email: comunica@evidenze.com. En todo caso, usted siempre podrá dirigirse igualmente para el ejercicio de estos derechos directamente a GSK. No obstante, sepa que en ese caso perdería su anonimato con GSK. GSK tiene su domicilio en calle Severo Ochoa, 2 (28760) Tres Cantos (Madrid). Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de GSK a través de este correo electrónico: EU.DPO@gsk.com

Por todo lo anterior, si en la llamada de registro confirma querer participar en el programa, confirmará prestar libremente, de forma expresa, voluntaria e inequívoca, su consentimiento para participar en este Programa.

NX-ES-BLM-EDTL-260001 (v1) 05/2026

7 Referencias

1 • Rodríguez-Lobato LG, de Daniel A, Pereira A, et al. Attrition rates and treatment outcomes in multiple myeloma: real-world data over a 40-year period. *Blood Cancer Journal.* 2025;15(1):103.

2 • Fonseca R, Usmani SZ, Mehra M, et al. Frontline treatment patterns and attrition rates by subsequent lines of therapy in patients with newly diagnosed multiple myeloma. *BMC Cancer.* 2020;20(1):1087.

3 • Chan CH, Yang X, Lyu M, et al. Targeting BCMA in multiple myeloma: A comprehensive review of immunotherapeutic strategies and clinical outcomes. *Mol Ther Oncol.* 2025;33(4):201044.

4 • Carpenter RO, Evbuomwan MO, Pittaluga S, et al. B-cell maturation antigen is a promising target for adoptive T-cell therapy of multiple myeloma. *Clin Cancer Res.* 2013;19(8):2048-60.

5 • Shrivastava T, Van Rhee F, Al Hadidi S. Targeting B Cell Maturation Antigen in Patients with Multiple Myeloma: Current Perspectives. *Onco Targets Ther.* 2023;16:441-64.

6 • Hungria V, Robak P, Hus M, et al. Belantamab Mafodotin, Bortezomib, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. *N Engl J Med.* 2024;391(5):393-407.

7 • Dimopolous MA, Beksac M, Pour L, et al. MM-1045: Updated Results From the Phase 3 DREAMM-8 Study of Belantamab Mafodotin (Belamaf) Plus Pomalidomide and Dexamethasone (BPd) vs Pomalidomide Plus Bortezomib and Dexamethasone (PVd) in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. *Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia.* 2025;25:S959-S60.

8 • Hungria V, Robak P, Hus M, et al. Belantamab mafodotin plus bortezomib and dexamethasone in patients with relapsed or refractory multiple myeloma (DREAMM-7): updated overall survival analysis from a global, randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2025;26(8):1067-80.

9 • Dimopoulos MA, Beksac M, Pour L, et al. Belantamab Mafodotin, Pomalidomide, and Dexamethasone in Multiple Myeloma. *N Engl J Med.* 2024;391(5):408-21.

10 • Ficha técnica BLENREP (Belantamab mafodotina); julio 2025. [Internet]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1251948002/FT_1251948002.html [Último acceso: febrero 2026].

11 • Sheikh S, Lebel E, Trudel S. Belantamab mafodotin in the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma. *Future Oncol.* 2020;16(34):2783-98.

12 • Dimopoulos MA, Terpos E, Boccadoro M, et al. EHA-EMN Evidence-Based Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with multiple myeloma. *Nat Rev Clin Oncol.* 2025;22(9):680-700.

13 • GEM-PETHEMA: Guía de mieloma múltiple. Grupo Español de Mieloma. 2ª edición. 2025.

14 • Hematoguía MiELOMA Versión 5.2. 2024. Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León.]Internet] Disponible en: https://www.sclhh.org/docs/pdf/consenso/guia%20mieloma%202024_version%20digital.pdf [Último acceso] 04mayo 2026.

15 • Mateos MV, Trudel S, Quach H, et al. Modification of belantamab mafodotin dosing to balance efficacy and tolerability in the DREAMM-7 and DREAMM-8 trials. *Blood Adv.* 2025;9(22):5708-19.

16 • Wahab A, Rafae A, Mushtaq K, et al. Ocular Toxicity of Belantamab Mafodotin, an Oncological Perspective of Management in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma. *Front Oncol.* 2021;11:678634.

17 • Terpos E, Trudel S, Mateos MV, et al. Practical Guidance on Clinical Management of Belantamab Mafodotin-Associated Ocular Events. *Am J Hematol.* 2025;100(10):1839-50.

18 • European medicines agency. Blenrep (belantamab mafodotin) EPAR [internet]. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/blenrep [último acceso: mayo 2026].

19 • Beksac M, Quach H, Hungria V, et al. Baseline ocular conditions and incidence of ocular events in patients with relapsed/refractory multiple myeloma from the DREAMM-7 and DREAMM-8 trials of belantamab mafodotine. PF759. EHA 2025 Congress | June 12–15, 2025.

20 • Joyce NC, Meklir B, Joyce SJ, Zieske JD. Cell cycle protein expression and proliferative status in human corneal cells. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 1996;37(4):645-55.

21 • Farooq AV, Degli Esposti S, Popat R, et al. Corneal Epithelial Findings in Patients with Multiple Myeloma Treated with Antibody-Drug Conjugate Belantamab Mafodotin in the Pivotal, Randomized, DREAMM-2 Study. *Ophthalmol Ther.* 2020;9(4):889-911.

22 • Hájek, R., Dimopoulos, M., Hungria, V., Robak, P., Hus, M., Kim, K. et al. Characterization of Ophthalmic Examination Findings (OEF) and Impact on Reading and Driving in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated with Belantamab Mafodotin (Belamaf). 2025. European Hematology Association congress. 2025. PS1761.

23 • Hájek R, Dimopoulos M, Hungria V, et al. Characterization of ophthalmic examination findings (OEFS) and impact on reading and driving in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) treated with belantamab mafodotin (BELAMAF). EHA Library. PS1761.

24 • Terpos E, Gavriatopoulou M, Ntanasis-Stathopoulos I, et al. Belantamab mafodotin, lenalidomide and dexamethasone (BelaRd) in newly diagnosed intermediate-fit and frail myeloma. *Blood.* 2025.

NX-ES-BLM-EDTL-260001 (v1) 05/2026

Para notificar una sospecha
de reacción adversa contacte
con GSK a través de
https://es.gsk.com/es-es/contacto/
o con el Sistema Español de
Farmacovigilancia a través de
https://notificaRAM.es

GSK